

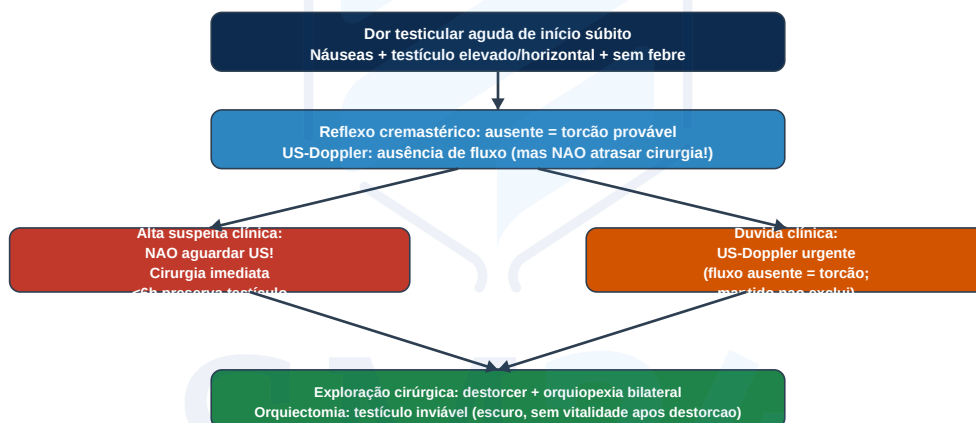
TORÇÃO TESTICULAR — CIRURGIA EM <6H

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Aspecto	Detalhe
Epidemiologia	Bimodal: neonato (torção extravaginal) e 12-18 anos (perinatal e adolescente); rara >30 anos
Mecanismo	Rotação do testículo no interior da túnica vaginal — compromete vascularização (artéria testicular)
Deformidade em sino (bell-clapper)	Fixação anômala da túnica vaginal — testículo 'flutua' livremente; causa predisposição
Clínica clássica	Dor testicular aguda + náuseas/vômitos + ausência de febre (inicialmente); pode ter dor abdominal baixa
Sinal de Prehn negativo	Elevação do testículo NAO alivia a dor — diferente da epididimite (Prehn positivo)
Reflexo cremastérico	Ausente no lado afetado — toque na coxa nao eleva o testículo (sens. 99%)

ALGORITMO — DICA TESTICULAR AGUDA

DOR TESTICULAR AGUDA — TORÇÃO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO



JANELA DE SALVAMENTO DO TESTÍCULO

TAXA DE SALVAMENTO X TEMPO DE TORCAO

- <6 horas: salvamento em >90% dos casos
- 6-12 horas: salvamento em 50-70%
- 12-24 horas: salvamento em <50%
- >24 horas: salvamento em <10% — quase sempre orquiectomia
- NAO perder tempo com exames se suspeita forte — cirurgia imediata
- Destorção manual no PS: temporária — cirurgia obrigatória mesmo se bem-sucedida

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diagnóstico	Diferencial chave
Epididimite aguda	Febre + disúria + início gradual; Prehn positivo; US: fluxo aumentado; >20 anos
Torção de apêndice testicular	Dor localizada no polo superior; 'ponto azul' visível; adolescente; US: apêndice torcido
Hérnia inguinal encarcerada	Massa inguinal palpável, não redutível; dor colicky; irradiada para escroto
Orquite viral (caxumba)	Parotidite associada; bilateral possível; adoles/adulto jovem não vacinado
Trauma escrotal	Histórico de trauma; US: hematoma; hematocele (sangue envolvendo testículo)

CONDUTA CIRÚRGICA E ORQUIOPEXIA

Exploração Cirúrgica

- Via: escrotal bilateral (sempre explorar contralateral)
- Destorção e avaliação de vitalidade por 5-10 min
- Testículo viável (rosado após destorção): orquiopexia com 3 pontos não absorvíveis
- Testículo inviável (escuro, sem recuperação): orquiectomia
- Prótese testicular: pode ser inserida no mesmo ato ou eletivamente
- Contralateral: orquiopexia bilateral SEMPRE (anatomia bell-clapper bilateral)

Manobra de Destorção Manual

- Indicada no PS como medida temporária enquanto aguarda cirurgia
- Rotação do testículo 'como abrindo um livro' — 180° para fora
- Pode precisar de 360-540° (1,5-3 voltas) para completa destorção
- Sinais de sucesso: alívio da dor, testículo desce ao polo inferior
- IMPORTANTE: cirurgia obrigatória mesmo se destorção bem-sucedida
- Em 1/3 dos casos a torção é sentido oposto — se piorar: girar para o outro lado

NAO ERRAR — PONTOS-CHAVE

TESTÍCULO AGUDO

- ☐ Jovem + dor testicular aguda + reflexo cremastérico ausente = torção testicular até prova em contrário
- ☐ US-Doppler: pode mostrar fluxo presente mesmo com torção (risco de falso negativo) — clínica primeiro
- ☐ NAO aguardar exames se quadro típico — cirurgia imediata = testículo salvo
- ☐ Orquiopexia bilateral: obrigatória — anomalia de fixação é bilateral
- ☐ Febre + gradual + Prehn positivo = epididimite — mas NUNCA tratar como epididimite sem certeza
- ☐ Torção neonatal: extravaginal, frequentemente ao nascer ou intraútero — dor menos evidente

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Adolescente de 15 anos com dor testicular esquerda aguda há 3 horas, náuseas, testículo elevado e reflexo cremastérico ausente. Qual é a conduta?

- A) US-Doppler urgente antes de qualquer conduta
- B) ATB para epididimite e reavaliação em 24h
- C) Exploração cirúrgica imediata sem aguardar US
- D) Analgesia e observação por 2h
- E) Beta-hCG para excluir tumor

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Intraoperatoriamente, o testículo após destorção permanece escuro após 10 minutos. Qual é a conduta?

- A) Aguardar mais 30 minutos — o testículo pode se recuperar
- B) Orquiectomia — testículo inviável; inserir prótese se desejo do paciente
- C) Orquiopexia assim mesmo — mesmo necrótico, preservar o testículo
- D) Injetar solução salina intratesticular
- E) Fechar sem intervenção adicional

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a orquiopexia contralateral deve ser realizada no mesmo ato cirúrgico?

- A) Para prevenir atrofia testicular pós-torção
- B) Porque a anomalia anatômica (bell-clapper deformity) é bilateral — mesmo risco de torção no testículo contralateral
- C) Para colher biópsia do testículo contralateral
- D) Para equilibrar o peso dos testículos
- E) Porque a lei brasileira exige bilateralidade

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o achado clínico com maior sensibilidade para torção testicular?

- A) Dor escrotal com início abrupto
- B) Reflexo cremastérico AUSENTE (sensibilidade ~99%)
- C) Testículo elevado
- D) Sinal de Prehn negativo
- E) Ausência de febre

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em qual faixa de tempo após o início da torção a taxa de salvamento testicular é >90%?

- A) Até 24 horas
- B) Até 12 horas
- C) Até 6 horas
- D) Até 3 horas somente
- E) A taxa é sempre a mesma independente do tempo

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Reflexo cremastérico ausente + dor aguda + testículo elevado = alta suspeita de torção. NAO aguardar US — exploração cirúrgica imediata. Cada hora de atraso reduz drasticamente a viabilidade. US pode ser normal em 20% das torções (fluxo diminuído mas presente).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Testículo inviável após destorção (escuro, sem recuperação de cor em 5-10 min, sem turgência): orquiectomia para evitar orquite autoimune e infecção. Prótese salina pode ser inserida no mesmo ato ou eletivamente se paciente/família aceitar. Contralateral: orquiopexia obrigatória.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Bell-clapper deformity é bilateral em 40-80% dos casos — testículo contralateral tem o mesmo risco anatômico de torção futura. Orquiopexia contralateral preventiva no mesmo ato protege o testículo sadio com risco mínimo de complicação. Padrão de cuidado em todas as diretrizes.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Reflexo cremastérico: toque na coxa medial superior eleva o testículo (arco cremastérico). Na torção: nervo e muscular cremáster comprometidos — reflexo ausente. Sensibilidade ~99% para torção. Especificidade ~66% (pode estar ausente em epididimite grave). Principal sinal clínico.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Janela terapêutica: <6h = salvamento >90%; 6-12h = 50-70%; 12-24h = <50%; >24h = <10%. Por isso, torção testicular é EMERGÊNCIA CIRÚRGICA. Qualquer dúvida: cirurgia — um testículo explorado desnecessariamente e um testículo salvo valem mais do que um testículo perdido por atraso.

SM24
Suporte ao Plantão Médico